

る。さらに近年はマイクロアレイ法を用いた多項目遺伝子検査が普及してきており、重症呼吸器感染症の場合に保険適用がある。

治療と予後

マイコプラズマ・ニューモニエやクラミジア・ニューモニエなどに対しては原因微生物に対する治療であるマクロライド系薬やテトラサイクリン系薬、ニューキノロン系薬などの投与を行う。インフルエンザウイルスに対しては抗インフルエンザウイルス薬の投与が行われる。RSウイルス感染症に対しては一部の基礎疾患を有する乳幼児への重症化予防のために遺伝子組換え抗RSウイルスモノクローナル抗体投与が行われる。2024 GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) Report では、米国疾病予防管理センター (Centers for Disease Control and Prevention: CDC) の推奨に順じ、60歳以上および/または慢性的な心疾患や肺疾患を有する患者に対しRSウイルスワクチンを推奨しており、本邦においても、重症化リスクの高い乳幼児や60歳以上の成人を対象にRSウイルスワクチンの接種が可能となっている。その他のウイルス感染症については有効な治療法はなく、安静や十分な水分補給が主な治療である。対症的治療として気管支拡張薬やステロイドの投与があるが、十分なエビデンスはない。

感染症による急性細気管支炎では、小児、特に乳幼児において予後不良な場合があるが、健常な成人においては重症化することは極めて少ない。この理由として全肺抵抗への末梢気道の関与が成人では5歳以下の

幼児に比べ少ないことが考えられている。しかし強い炎症が細気管支領域に生じた場合、成人であっても予後不良となることもある。

Advanced

■RSウイルスワクチンの最新のエビデンス

60歳以上の成人24,966人を対象に実施された国際共同第Ⅲ相臨床試験において、RSウイルス感染による下気道疾患全般に対する有効性は82.6%、重篤な下気道疾患に対する有効性は94.1%と報告されていた^{A)}。米国8州の電子カルテベースのネットワークを用いて、2023年10月から2024年3月までにRSV検査を受けた60歳以上の成人におけるRSV様疾患に対する有効性が検証された。免疫不全のない60歳以上の入院28,271例において、RSVワクチンの有効性は80% (95%信頼区間 (CI): 71~85) で、重症 (ICU入室または死亡、あるいはその両方) に対する有効性は81% (95%CI: 52~92) であった。免疫不全状態の入院8435例における有効性は、73% (95%CI: 48~85) であり、年齢層や製剤の種類によらず同様の有効性が示された^{B)}。

A) Papi A, et al: N Engl J Med 2023; 388: 595-608.

B) Payne AB, et al: Lancet 2024 Oct 19; 404(10462): 1547-1559

文 献

- 1) Ryu JH, et al: Am J Respir Crit Care Med 168: 1277, 2003
- 2) Fraser RS, et al (eds): Bronchiolitis. Fraser and Paré's Diagnosis of Diseases of the Chest, 4th Ed, Saunders, p2321-2357, 1999